

6 胸膜肥厚斑, 胸膜斑 pleural plaque

到達目標

- 胸膜肥厚斑の病態を理解し、石綿曝露歴の詳細と関連を聴取・評価できる
- 胸膜肥厚斑と、他の石綿関連疾患、結核性胸膜炎の診断・鑑別ができる
- 胸膜肥厚斑が石綿曝露歴の根拠となることを知り、石綿健康被害救済制度に対応できる

病因・病態・疫学

胸膜肥厚斑は胸膜プラークとも呼ばれ、壁側胸膜中皮下に生じる不規則な白板状肥厚で、病理学的には中皮で覆われた膠原線維束がバスケットの網目状に配列し、細胞成分を有していない。壁側胸膜の線維性の盛り上がり状態を表したものであり、呼吸機能障害を伴わないため、疾患でなく病変として取り扱われる。

本邦では石綿曝露によってのみ発生すると考えられている。15～30年の曝露により発生し20年以降から石灰化がみられる。石綿関連の病変のなかでも高頻度にみられるものであり、中皮腫と異なり低濃度曝露でも発生する。胸膜肥厚斑自体が中皮腫に転化することはないと考えられている¹⁾。

症候・身体所見

一般的には自覚症状はなく、職場検診や他疾患の精査で胸部X線写真や胸部CTを施行した際に偶然発見される。呼吸機能に及ぼす影響はほとんどないとされ

ている¹⁾。

診断・検査

胸部単純X線写真で、結節状、線状、索状、菱形、地図状、分葉状陰影と石灰化を認めるが(図1a)、検出率は14～54%と低い。一方、胸部CTでは壁側胸膜の限局性、平板状で平滑な1～9mm程度の胸膜肥厚を認め、62%に石灰化が観察され(図1b)、石灰化がなくてもCT値が高い(筋層以上)ため、検出率は85%と高く特異度も優れている。

好発部位は胸壁背側～外側にかけての第6～第10肋骨の範囲、横隔膜、傍脊椎領域であり、進行例では心嚢にもみられる。肺尖と横隔膜肋骨角にみられないのが結核性胸膜炎との大きな違いである。また、結核性胸膜炎の胸膜肥厚・石灰化は主に臓側胸膜にみられるが、胸膜肥厚斑は壁側胸膜に限られる。なお、CTでも検出不能で胸腔鏡検査や手術時の開胸、剖検で初めて指摘されることもある。

治療

特に症状や呼吸機能の著しい低下もないため、あえて治療を行うことはない。

胸膜肥厚斑診療の意義

胸膜肥厚斑そのものは自覚症状がなく軽視されがちであるが、長期の低濃度石綿曝露の優れた指標であ



a.



b.

図1 胸膜肥厚斑のX線写真とCT(70歳代、男性、水道工事業、アスベスト曝露歴あり)

a: 両側性の石灰化を伴う線状・斑状影を認める。側胸部では胸膜肥厚、石灰化を観察でき背部胸膜病変の存在が疑われる。b: 両側背部、横隔膜側の石灰化を伴う壁側胸膜の平滑な肥厚を認める。